

العنوان : =

الحي / المدينة : الخصوص

المحافظة : القليوبية

تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

رقم البطاقة : 27203231401806 رقم التلفون : 01000270396

العمر (تاريخ الميلاد) : 23-03-1972 **المهنة :** ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (_____)

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمى وتلطيفى [6579] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : -----

GR1-E
روستاقی کمیٹی
نئی تحصیل
ضلع مظفر
صحة الایات روستا
اللجنة و مدير

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس

وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / 2 ----- / 2 ----- / 2.1 ----- / 2.1

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

قسم :

نَفَقَات :

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نعمه عبدالوهاب محمود جليلا National ID: 27203231401806	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

Patient's Name: Naima Abdel Wahab Mahmoud Jaljal
Date: 2026-08-08
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: 54 year-old female with negative family history, complaining of left breast hardness of couple of months duration.

Findings:

Right breast.

- Scattered densities of glandular tissue (ACR B).
- no spiculations masses microcalcifications or assymetries .
- UOQ intramammry LN .
- Ultrasound demonstrated heterogeneous breast parenchyma with small UOQ non specific intra mammary ln , No solid lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast.

- Scattered densitieds of fibroglandular tissue (ACRB)
- UIQ dense rounded partially circumscribed lesion measuring 1.3x1.4 cm with no associated suspicious calcifications .
- Small faint well cicumscibed oval lesion is seen in the UOQ.
- Ultrasound demonstrated UIQ breast 10 o'clock rounded irregular hypoechoic solid mass lesion with surrounding echogenic halo, posterior acoustic shadowing measuring about 1.3x1.4 cm 8cm from the nipple .
- normal skin nipple areola complex
- non specific axillary LNS..

Conclusion:-

- *Right breast (BIRADS 2): intra mammary LN .*
- *Left breast (BIRADS 4c) : UIQ 10 O'CLOCK suspicious mass .*

Recommendation:-

- *For biopsy and histopathological correlation.*

Prof.MONA ZAKY





Patient Name	نعمه عبدالهلى محمد	Case No.	360015
Sex/Age	Female 54 Y	Patient No.	26137
Registered Date	23/8/2026 03:17:07 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	15/9/2026 03:29:15 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	26/9/2026 09:50:56 AM	Pathology No.	2666/26

Pathology Report

Clinical Data: Left breast UOQ mass (BIRADS 4c).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 20/08/2026, at 1:45 pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:
- Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.2 cm & 1.0 cm long, totally submitted.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;

- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma.

- Histologic grade: 2 (differentiation 2, pleomorphism 2, mitosis 2).

- DCIS: Absent.

- Microcalcification: Absent.

- Angioinvasion: Absent.

- Perineural invasion: Absent

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).

- PR: Strong nuclear reaction in 15% of tumor cells (score 6/8).

- Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).

- Ki67%: 10%.

Conclusion:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).

- PR: Positive (score 6/8).

- Her2: Negative (score 0).



Patient Name	نعمه عبدالعاطي محمود	Case No.	360015
Sex/Age	Female 54 Y	Patient No.	26137
Registered Date	23/8/2026 03:17:07 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	15/9/2026 03:29:15 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	26/9/2026 09:50:56 AM	Pathology No.	2666/26

- Ki67%: 10%.

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%

and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+

(Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the

invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within >

10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the

the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the

invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.



خريطة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - جوار مبنى القصر الطبي - مصر الجديدة - القاهرة 5 - مصر
 Room No. (4) - First Floor-Building No. 987 - Nile Corniche - Mistr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient's Name:

Naima Abdel Wahab Mahmoud Jaljal

Date:

2026-08-08

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: 54 year-old female with negative family history, complaining of left breast hardness of couple of months duration.

Findings:

Right breast.

- Scattered densities of glandular tissue (ACR B).
- no spiculations masses microcalcifications or assymetries .
- UOQ intramammy LN .
- Ultrasound demonstrated heterogeneous breast parenchyma with small UOQ non specific intra mammary ln , No solid lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNS.

Left breast.

- Scattered densities of fibroglandular tissue (ACRB)
- UIQ dense rounded partially circumscribed lesion measuring 1.3x1.4 cm with no associated suspicious calcifications .
- Small faint well circumscribed oval lesion is seen in the UOQ.
- Ultrasound demonstrated UIQ breast 10 o'clock rounded irregular hypoechoic solid mass lesion with surrounding echogenic halo, posterior acoustic shadowing measuring about 1.3x1.4 cm 8cm from the nipple .
- normal skin nipple areola complex
- non specific axillary LNS..

Conclusion:-

- Right breast (BIRADS 2): intra mammary LN .
- Left breast (BIRADS 4c) : UIQ 10 O'CLOCK suspicious mass .

Recommendation:-

- For biopsy and histopathological correlation.

Prof.MONA ZAKY

23456789

۱۰۰

مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ

- Post-Test

ography